

无异常,心电图:肢体Ⅱ导联 QRS 波群呈 rS 型。余无异常。拟诊为格林-巴利氏综合征,给庆大霉素肌注,氢化可的松 200 毫克静滴治疗 29 小时,病情无好转。患者出现呼吸道分泌物增多,瞳孔缩小,腹痛,经反复追问病史,患者 10 天前用敌百虫 30 片加入白酒中溶解后外搽阴囊皮肤治疗阴囊湿疹,遂按有机磷中毒治疗,静滴解磷定、阿托品治疗无效,于入院后第 3 天因呼吸衰竭死亡。

本例误诊原因: 1. 敌百虫属中度毒性有机磷农药,皮肤涂搽吸收较慢,搽于皮肤无局部刺激征或无特殊气味。故搽毒史常被患者遗忘或认为与现症无关。2. 中毒症状不典型。本例以颈部肌群功能障碍为首发症状,而无瞳孔缩小、肌震颤等有机磷中毒的特异症状与体征,常被误诊为消化道疾病、神经系统疾病和感染性疾病^[1]。3. 临床医生对此类中毒认识不足或忽视毒物接触史的询问,当临床出现呼吸困难,分泌物增多、瞳孔缩小、腹痛时才获知病人病前有搽毒史,按有机磷中毒治疗,但终因误诊时间较长,出现呼吸衰竭抢救无效死亡。

呼吸衰竭是外搽敌百虫皮肤吸收中毒死亡的主要原因^[2]。由于敌百虫具有亲神经毒性,可从中枢及外周两个方面致呼吸衰竭^[3]。故对原因不明的颈部肌群功能障碍,头昏,四肢乏力时应考虑敌百虫中毒的可能。

参 考 文 献

1. 付红春等:临床错诊错治 1992; 5(3):130
2. 陈旭春等:医师进修杂志 1991; 14(4):48
3. 殷大奎:四川医学 1985; 6(4):238

重视药物相互作用减少临床不合理用药

开封锅炉厂卫生所 缪丽庆
开封高压阀门厂医院 蒋慕文

随着医药科学的迅速发展,基层医疗单位临床用药日趋复杂。药物的配伍应用也逐渐增多,合理的药物配伍能提高药物的疗效,减少不良反应,在疾病的治疗上起了很大的作用,但不合理的合并用药将因“药物相互作用”而使毒性增加或药效降低,给患者带来不必要的危害。我们回顾性分析了一些基层医疗单位的用药处方 14348 张,发现属于不合理用药范围的相互作用 25 对,共 462 张,处方占调查分析处方的 3.22%。现分述如下。

一、药物相互作用使毒性增加

庆大霉素与碳酸氢钠联用:庆大霉素在碱性条件下作用加强,当 PH 8.5 时比 PH 5 时杀菌作用强 100 倍,同时对肾脏和听神经的毒性也增加,而且碳酸氢钠可碱化尿液,使庆大霉素排泄减少,半衰期延长,故两药合用时如不减少用量,就会产生毒副反应。

庆大霉素与速尿联用:速尿为强利尿药,对听神经有毒性,与庆大霉素合用时,可使耳毒性作用增强。

硫甲丙脯酸与β受体阻滞剂合用^[1]:应用硫甲丙脯酸的患者交感神经系统对维持血压起着非常重要的作用,β受体阻滞剂能够影响交感神经活性故两药合用应慎重。

复方新诺明与扑热息痛合用:当复方新诺明与扑热息痛合用时,易形成变性血红素而出现贫血。

异搏定与心得安合用:可因两者对心肌和传导抑制作用相加而引起不利的血液动力学改变,常导致低血压、严重心动过缓、心肌收缩力减弱,甚至心跳骤停^[2]。

红霉素与氨茶碱配伍:氨茶碱进入体内后形成茶碱及乙二胺,红霉素可降低茶碱的清除率。有报道给予红霉素 200~250 mg qid 1 周后,茶碱清除率下降 25.8%,而使血清中茶碱浓度增加,出现毒性反应,故两药并用须注意观察。

氯霉素与甲氧咪胍合用:氯霉素能抑制蛋白质合成,使骨髓中铁络合酶活性下降,导致铁的吸收障碍,从而抑制了骨髓的造血机能,易使机体发生再生障碍性贫血。甲氧咪胍也可导致骨髓抑制^[3],若两药合用则上述不良反应加重。

甲氧咪胍与心得安合用:甲氧咪胍的咪唑环与细胞色素 P 450 结合而抑制肝微粒体酶的活性,同时还通过阻断血管上的 H₂受体,从而减少肝动脉的血流量^[4],抑制心得安的代谢,使心得安的血药浓度增加 3~6 倍,结果可发生严重的心动过缓及低血压,故甲氧咪胍不宜与心得安合用。必须合用时应减小心得安的剂量。

糖皮质激素与保泰松合用:糖皮质激素类药物能增加儿茶酚胺的缩血管反应,收缩胃粘膜血管使胃壁的血液循环发生障碍,刺激胃酸和胃蛋白酶的分泌,降低胃与十二指肠粘膜对胃酸的抵抗力,同时因其影响人体蛋白质的分解与合成作用,而阻碍了组织修复,使溃疡愈合迟缓,保泰松能引起胃与十二指肠溃疡,两药合用有引起胃和十二指肠溃疡的危险。

痢特灵与左旋多巴合用:左旋多巴为单胺类药物,痢特灵系单胺氧化酶抑制剂,口服后可抑制脑组织内的单胺氧化酶,使 5-羟色胺、多巴胺和去甲肾上腺素

腺素等单胺类神经递质的氧化、破坏受阻,两药合用可引起恶心、呕吐、呼吸困难、头晕、头痛、心律失常和血压升高⁽⁵⁾,故两药不宜合用。

乙胺碘呋酮与异搏定、硫氮草酮合用:可协同抑制窦房结功能和延长房室结有效不应期,导致心动过缓和加重房室传导阻滞,甚至引起心脏停搏的严重后果,故乙胺碘呋酮与异搏定或硫氮草酮不宜合用⁽⁶⁾。

二、联合用药发生药理性拮抗使药效降低

青霉素与四环素类、红霉素、氯霉素等联合应用:这种联用忽视了青霉素为细菌繁殖期杀菌剂,而四环素、红霉素、氯霉素等为抑菌剂,目前认为不宜将繁殖期杀菌剂与抑菌剂联合应用。因为细菌受到抑菌剂的作用处于静止状态。这时繁殖期杀菌剂就发挥不了作用,结果使疗效降低。临床上如确属病情需要,应先完成青霉素治疗,再用四环素类、红霉素、氯霉素等为妥。

庆大霉素与青霉素配伍:庆大霉素分子中的糖氨基与青霉素的 β -内酰胺环发生交联,生成灭活性的氨基酰胺化合物,而使庆大霉素灭活,故两药不宜配伍。

洁霉素与红霉素合用:两药均作用于菌体蛋白质合成过程中的核糖体 50 S 亚基而阻碍蛋白质合成,两药合用时可在作用部位出现竞争而不能产生协同作用,故两药不宜合用。

复方新诺明与酵母片合用:酵母片中含有大量的 PABA,故可使复方新诺明的抗菌疗效下降。

四环素类药物与硫酸亚铁、胃舒平、葡萄糖酸钙等药物合用:因四环素类药物易与二价或三价金属阳离子(Ca^{++} 、 Fe^{++} 、 Al^{+++} 等)形成络合物,从而影响了四环素类药物从肠道吸收,明显地降低其生物利用度,使疗效降低。

黄连素、土霉素、复方新诺明与矽炭银、次碳酸铋等配伍:由于炭的孔隙多,表面积大若与抗菌药物合用,可因药用炭的吸附作用,而使抗菌药物吸收减少降低疗效。次碳酸铋在肠道内形成保护膜,覆盖粘膜表面妨碍抗菌药物发挥作用。

呋喃唑啉、磺胺类药物与胃舒平合用:当胃舒平与呋喃唑啉或磺胺类药物合用时,可妨碍或延缓呋喃唑啉及磺胺类药物在胃肠道的吸收使抗菌作用减弱。

维生素C与维生素B₂合用:由于维生素C具有较强的还原性,在碱性溶液中易于氧化失效,而维生素B₂为两性化合物,其氧化性大于还原性,还具有生物碱的性质,两药同服将产生氧化还原反应,使维生素B₂破坏为还原型B₂而无疗效。

胃蛋白酶与胃舒平、碳酸氢钠等碱性药物合用:

胃蛋白酶在 pH 3.5~4.5 时活力最强,PH5 以上全

部失效。故胃蛋白酶不应与碱性药物合用。

乳酶生与红霉素、土霉素、黄连素等抗菌药物合用:乳酶生是活的乳酸杆菌制剂,与抗菌药物合用时乳酸杆菌活性被抑制,可使乳酶生降效。

双氢克尿塞与甲磺丁脲合用:双氢克尿塞能直接抑制胰岛 β 细胞的功能,抑制胰岛素释放,使血糖升高从而使甲磺丁脲的降血糖作用降低,故两药不宜合用。

巯甲丙脯酸与消炎痛合用:巯甲丙脯酸能促进具有血管扩张作用的前列腺素合成,消炎痛可抑制前列腺素的合成,两药合用可使巯甲丙脯酸的降血压作用明显减低,两药不宜合用⁽¹⁾。

在疾病治疗过程中,大多数情况下都是采用多种药进行治疗的。然而有关资料表明^(7,8),并用药物的种类与药物不良反应发生率呈正相关。并用 1~5 种药物时,不良反应发生率为 3.3%至 18.6%;并用 6 种以上药物时,不良反应增至 19.8%~81.4%。因此药物之间的相互作用必须引起我们广大基层医务工作者的足够重视,避免不恰当的药物配伍,减少临床不合理用药现象。

参 考 文 献

1. 蒋慕文等:开封医药杂志 1991; 4:48
2. 朱毓仁:医师进修杂志 1985; 1:38
3. 周政:中级医刊 1983; 9:40
4. 王世俊等:药学通报 1984; 6:35
5. 黄振东:中国医院药学 1987; 7:305
6. 严序经等:实用内科杂志 1987; 7(1):1
7. Richens A; J Clin Pathol 28 Suppl 1973; (9):94
8. Avery GS: Drug Treatment Adis Press Sydney NY 1976

66 例创伤外科患者 血液流变学观察

解放军第196医院 王亚章 茅玉琴*

血液流变学检测在心脑血管等内科疾病中应用较多,而在外科领域中则报道较少。笔者用无锡县电子仪器二厂生产的 SD2-3 型粘度计和 wyA-2 型压积仪等仪器,对 66 例因车祸、刀伤、枪伤而住院的患者进行检测,以期观察变化特点,现将结果报告如下。